小規模多機能型居宅介護 マニュアル記入シート

事業所：小規模多機能型居宅介護

記入者：（管理者名）小川　萌

記入日：**R8年6月11日　追記6/16**

このシートに記入していただいた内容を、スタッフ向け業務マニュアルに反映します。

記入の締切：**6月末まで**

できた時点でアップロードしていただいて構いません。

内容について確認・調整が必要な場合は、こちらから都度ご連絡します。

分からない部分は空欄でも構いません。現状の慣習・やり方をそのまま書いてください。

共通項目

※ 以下の内容は、法人として方針を統一する際の参考にします。現在のやり方をそのまま教えてください。

Q1. 利用者急変時の対応手順

利用者が意識を失った・呼吸が止まった・大きく転倒したなど、緊急を要する状態になった場合について教えてください。

A.日中…バイタル測定、全身状態の観察、安全確保を行い管理者及び管理者補佐、看護師へ報告。Drへ上申し指示を受ける。

夜勤帯…バイタル測定、全身状態の観察、安全確保を行い管理者及び管理者補佐へ報告。Drへ上申し指示を受ける。

Q2. サービス中止・管理者報告の判断基準（バイタル）

以下のバイタル値で、サービスを中止したり管理者に報告する基準を記入してください。

項目	サービス中止・報告の基準
体温（℃）	37.5℃以上
血圧収縮期（mmHg）	
脈拍（回/分）	
SpO_2（%）	

備考・補足：

現状、発熱以外のバイタル値は基準が曖昧である。

毎朝体温、血圧及び脈拍の測定を行い、バイタル記入表に記入したものを看護師が確認し、再検などを行っている。

Q3. 服薬管理の手順

薬の保管場所・服薬前の確認事項・飲めなかった場合の対応について教えてください。

A.薬の保管…事務所看護師用デスク引き出し

服薬準備…看護師が翌日分まで朝・昼・夕、眠前の各ケースに準備を行う。

服薬の流れ…

①食事前にキッチンカウンターに薬BOXごと移動。

②薬ケースから取り出す際、目視で日付、名前を確認する。

③本人の横で薬包から取り出し服薬を行う。

服薬が行えなった際の対応…看護師へ報告を行う。

夜勤帯は翌日行っている。

Q4. 事故・ヒヤリハット発生時の対応手順

事故またはヒヤリハットが起きた場合の初動から記録までの順番を教えてください。

A.

①状況確認を行い、バイタル測定などの全身状態を観察する。

②他スタッフに応援を求める。

③看護師へ報告

④事故報告書を当時中に記入、提出。

⑤必要に応じて管理者及び管理者補佐に報告。

事業所固有項目

Q5. 夜間（一人対応時）に管理者を呼び出すべき状況の基準

宿泊利用者がいる夜間に一人で対応している際、管理者を呼び出す・連絡を入れるべき場面の基準を教えてください。

A.

現時点で基準は曖昧である。

個々の職員の感覚で運用しているのが実情である。

判断に迷った際、不安を感じた際は**24**時間体制で管理者補佐の業務用携帯に連絡をするように

共有をしている。

AEDはサービス付き高齢者住宅に配置している。

呼び出しが必要な状況（例として当てはまるものに○、修正してください）：

〇利用者が転倒し、外傷・痛みの訴えがある

〇意識・呼吸の異常を認める

〇バイタルが基準値を超え、かつ本人の状態が平常と異なる

〇**119**番を要請した

〇宿泊利用者が複数人同時に体調不良になった

〇対応に迷い、一人では判断できない場面

夜間管理者の連絡先：

080-9795-4368　管理者補佐業務携帯にて**24**時間応対。

Q6. 通い・訪問・泊まりの切り替え判断

通い・訪問・泊まりを切り替える判断はどのようにしていますか？誰が判断し、どのように連絡しますか？

A.管理者補佐より介護支援専門員（今井**CM**）、管理者（稲田代表兼**CM**）に連絡を行い、総合的に判断し、管理者補佐か看護師よりキーパーソン及び本人に連絡（基本は電話）を行う。

よくある切り替えのケースと判断基準：

体調不良で通いを泊まりに変更など → 管理者補佐がキーパーソン、本人及び**CM**に連絡し調整

家族の急用で泊まり追加 → 管理者補佐判断で当日対応を行う。

Q7. 訪問中に利用者宅で応答がない場合の手順

訪問時にインターホンを鳴らしても応答がない・ドアが開かない場合の対応手順を教えてください。

A.

職員には通常と異なる際には一人で自宅内には入らないように指導をしている。

①インターフォンや扉をたたくなどを複数回し呼びかける。

②窓越しや周辺環境及び室内を確認する。

③①と②を並行しながら事業所に連絡を入れ、事業所から本人及びキーパーソンに

連絡を入れる。

④管理者、管理者補佐、**CM**に報告し指示を仰ぐ。

Q8. 送迎の段取りと変更時の対応

「送迎の順番・ルートはどう決めるか」「当日の変更（キャンセル・追加）が出た場合の対応」「送迎時に利用者宅で確認すること」を教えてください。

A.

ルートの組み方：

前日に翌日の業務分担用のホワイトボードに記載する。

当日、ホワイトボードと週間サービス表にて確認を行う。

出発前の車の確認：

現在、特に規定なし。

利用者宅での確認：

現在、特に規定なし。

当日変更が出た場合：

現在、特に規定なし。

Q9. 当日キャンセルへの対応手順

「キャンセルの連絡が来たら誰に・どのように報告するか」「送迎車がすでに出発していた場合の対応」「その後の記録はどうするか」を教えてください。

A.

①利用者・家族からキャンセルの連絡が来たら、連絡を受け付けたスタッフが送迎担当者に報告する

②送迎車がすでに出発している場合は、フロア担当が送迎担当者に電話でキャンセルを伝える

③キャンセルの理由・連絡者名・連絡を受けた時刻を記録に残す

④連続してキャンセルが続く利用者については、管理者かCMが家族に状況確認の連絡を入れる

Q10. ケアマネへの定期報告のタイミングと方法

「何をもって報告のタイミングとするか」「どの手段で連絡するか」「報告した内容はどこに記録するか」を教えてください。

A.

CMとは常に情報共有を図っており、小さな出来事であっても報告及び相談を行っている。

記録に関してはCMは支援経過に入力をしている。申し送りノートに記入をし、他スタッフとも情報共有を図っている。

Q11. 入浴介助の手順と設備

使用している入浴設備・介助の具体的な手順・特に注意していることを教えてください。

A.

２人介助が必要な利用者は入浴者一覧表（脱衣場に配置）にて確認を行う。

使用設備：一般浴（介助浴）／機械浴

入浴前の確認事項：

①入浴予定者の確認②バイタル測定

介助の手順（一般浴）：

①バイタルチェック、体調の確認する

②脱衣所・浴室の温度を一定にする

③脱衣所の誘導し脱衣介助をする

④洗身、洗髪を行う。全身状態の確認を行う。
⑤浴槽への介助を行う。
⑥入浴中は声掛け及び見守りを行う。
⑦浴槽からの介助を行う。

⑧脱衣所へ誘導し着衣介助をする。

⑨乾髪を行い、フロアへ誘導。
⑩水分補給提供をする。

機械浴の場合：

①バイタルチェック、体調の確認する

②脱衣所・浴室の温度を一定にする

③入浴用ストレチャーへ移乗し脱衣介助をする

④洗身、洗髪を行う。全身状態の確認を行う。
⑤浴槽への介助を行う。
⑥入浴中は声掛け及び見守りを行う。
⑦浴槽からの介助を行う。
⑧入浴用ストレッチャー上にて着衣介助をする。
⑨車いす等に移乗し乾髪を行い、フロアへ誘導。
⑩水分補給提供をする。

Q12. 移乗・移動介助の手順と注意点

「ベッドから車椅子への移乗」「トイレ誘導時の介助」について、当事業所での具体的な手順と特に注意していることを教えてください。

A.

●ベッド⇒車いす

①声掛けを行う。

②利用者の腕を胸の上で組み、足を立てるなどできる限り体をコンパクトにする。

③ベッド端まで水平移動させる。

④利用者の体の向きを変える。

⑤テコの原理を活用して上体を起き上がらせる

利用者の首の下と膝の裏に手を回し体を支える。

尻を支点にし、掛け声とともに利用者の体重と遠心力を利用して回転させる。

⑥ベッドの高さを調整する。

⑦車いすの角度を調整する

ブレーキがかかっているか、フットレストは上がっているか確認 。

⑧足の角度を調整する

車いすに移る前に、足の角度をまっすぐではなくやや斜めにしておく。

⑨車いすに移動することを伝える

⑩掛け声とともに車いすに移乗する

支持基底面を大きく取り、腰を落として重心を下げ、利用者に密着し、重心を近づける。

⑪尻の位置を整える

2名介助が必要な利用者:

体重や体格、禁忌動作にて2人介助を必要とする場合、無理なく応援を頼む。

2人介助を要する利用者については、**OJT**にて情報共有を行うとともに、入浴一覧表に印をつけ共有を図る。

転倒防止の注意点:

環境面…床の濡れ、障害物の有無の確認を行う。

介護者…靴は踵のあるものを使用。

要介護者…入眠導入剤や抗精神薬のリスクファクターの把握。

サイズに合った靴の着用。

精神状態を確認し、精神的に落ち着いた状態で介助を行う。

身体状況に応じた歩行補助具の使用。

Q13. 食後の口腔ケアの手順

「誰が」「いつ」「何を使って」「どの順番で行うか」を教えてください。

A.

担当者とタイミング

毎食後、フロア対応スタッフが実施する。

使用する用品:

歯ブラシ・歯磨き粉・コップ・ガーグルベースン・スポンジブラシ・必要に応じて吸引機。

手順：

①準備と声かけ

②義歯がある場合は外す

③口腔内の観察

④ブラッシング

Q14. 認知症利用者のBPSD（徘徊・暴言等）への対応方針

徘徊・帰宅願望・暴言・興奮などが見られた場合の対応について、当事業所でのやり方を教えてください。

A.

徘徊・帰宅願望が見られた場合：

否定せず穏やかに声かけを行う。

外に出ようとする場合は一緒に散歩に行くなど場面を転換させる。

夜間の場合は管理者補佐に報告する。

暴言・興奮が見られた場合：

物理的に距離を保ちながら見守りを行う。

一人で対応できないと判断した場合は他のスタッフを呼ぶか管理者補佐に報告する。

管理者への報告基準：

他の利用者や自身への危険が生じる可能性がある場合・一人では対応が困難な場合・自身で判断がつかない場合、ケガや転倒が発生した場合は即時報告する。